

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/25/6443

הצעת חוק הקמת חדר מיון בקריית שמונה, התשפ"ו–2026

1. מטרה
חוק זה מטרתו להנגיש שירותי רפואה דחופה לתושבי קו העימות הצפוני, וביניהם תושבי קריית שמונה, באמצעות הקמת חדר מיון בעיר.
2. הגדרות
בחוק זה –
"חדר מיון" – כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996;¹
"השרים" – שר האוצר ושר הבריאות.
3. הקמת חדר מיון
על אף האמור בכל דין, שר הבריאות יקים חדר מיון בעיר קריית שמונה בתוך שנה מיום תחילתו של חוק זה.
4. מפרט חדר המיון
שר הבריאות, באישור ועדת הבריאות של הכנסת, יקבע הוראות בדבר אמצעי רפואה וציוד מציל חיים שיהיו בחדר המיון, לרבות מספר מיטות האשפוז.
5. צוות חדר המיון
צוות חדר המיון יכלול את אלה:
(1) רופא המתמחה ברפואה דחופה, שמורשה לעסוק ברפואה לפי סעיף 2 לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז–1976;²
(2) אחות מוסמכת כמשמעותה בתקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים), התשמ"ט–1988;³
(3) "פרמדיק" – כהגדרתו בתקנות הרופאים (כשירות לביצוע פעולות חריגות), התשס"א–2001.
6. החזקת חדר המיון והפעלתו
חדר המיון בקריית שמונה יופעל ויתוחזק על ידי משרד הבריאות או על ידי גורם מוסמך מטעמו ויתוקצב מתקציב המדינה.
7. מועדי פעילות
חדר המיון בקריית שמונה יפעל שבעה ימים בשבוע במהלך כל שעות היממה.

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594.

³ ק"ת התשמ"ט, עמ' 277.

⁴ ק"ת התשס"א, עמ' 1020.

ביצוע ותקנות 8. השרים אחראים על ביצוע הוראות חוק זה, והם רשאים להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

דברי הסבר

העיר קריית שמונה, עמדה בחזית המערכה הביטחונית בצפון לאורך תקופה ארוכה. עם תחילת תהליך השיקום של העיר והאזור כולו לאחר המלחמה, ברור מתמיד כי לא ניתן להסתפק עוד בפתרונות זמניים או במוקדי רפואה. החוסן האזרחי של תושבי הצפון, השבים לביתם, מושפע גם מהיכולת המדינה לספק שירותי רפואה חירום זמינים, איכותיים ומצילי חיים בקרבת מקום.

המצב הקיים והצורך המבצעי-רפואי

במשך שנים הובטח לתושבי קריית שמונה והסביבה חדר מיון קדמי שיפעל במתכונת מלאה. בפועל, הוקם רק מוקד רפואי הפועל בשעות מוגבלות בלבד. המציאות המלחמתית הוכיחה כי המרחק הגאוגרפי מבית החולים "זיו" בצפת בשילוב עם חסימות צירים פוטנציאליות וסיכונים ביטחוניים, והעומס הכבד תחתיו הוא נתון, יוצרים "וואקום רפואי" מסוכן. תושבי העיר והסביבה, חיילי צה"ל הפרוסים בגזרה וכוחות הביטחון, נאלצים להסתמך על פינוי ארוך ומורכב במקרים של רפואה דחופה – מצב שעלול לעלות בחיי אדם בדקות הקריטיות ("שעת הזהב").

שיקום וחוסן קהילתי

הקמת חדר מיון בקריית שמונה היא נדבך קריטי בתוכנית השיקום הלאומית לצפון. ללא תשתית רפואית הולמת, יתקשו משפחות וצעירים לשוב ולהשתקע בעיר. העוגן הבריאותי מהווה הצהרה שלטונית על מחויבות המדינה לביטחונם האישי של אזרחיה בפריפריה. מעבר להיבט מציל החיים, הקמת המיון תוריד מהעומס המוטל על המערך הרפואי בצפת ותאפשר שירותי רפואה טובים יותר לאוכלוסייה שסבלה מהזנחה רבת שנים ומאפליה בחלוקת משאבי הבריאות.

עיקרי הצעת החוק

מוצע להקים בקריית שמונה חדר מיון, שיכלול ציוד רפואי מתקדם, מכשירים מצילי חיים וצוות רפואת חירום אשר יפעל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. האחריות על הקמת חדר המיון והפעלתו תוטל ישירות על משרד הבריאות, והוא יתקצב מתקציב המדינה. שר הבריאות, באישור ועדת הבריאות של הכנסת, יקבע הוראות בדבר אמצעי רפואה וציוד מציל חיים שיהיו בחדר המיון, לרבות מספר מיטות האשפוז, כדי להבטיח שחדר המיון ייתן מענה הולם לאיומים הביטחוניים והרפואיים הייחודיים לאזור. הצעת חוק זו מוגשת תוך התמקדות בצרכי השיקום הדחופים של העיר קריית שמונה בעקבות המלחמה. לאחר הטלטלה שעברה, מדינת ישראל אינה יכולה לאפשר מצב שבו מקום מגוריו של אדם בגבול הצפון יקבע את סיכויי ההישרדות שלו באירוע רפואי דחוף.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת קרן ברק (פ/23/417) ועל ידי חבר הכנסת מאיר כהן וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/748), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת קרן ברק (פ/24/210), על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/24/1769) ועל ידי חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3883) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/25/939), על ידי חברת הכנסת דבי ביטון וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/2548); הוסרה מסדר היום ביום י"א בסיון התשפ"ג (31 במאי 2023), על ידי חבר הכנסת יונתן מישרקי (פ/25/2821), על ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/25/3161) על ידי חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי (פ/25/3256) ועל ידי חברת הכנסת דבי ביטון וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/3870).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ו (05.01.2026)